

Fibromyalgia

纖維肌痛症 | NEJM Clinical Practice

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-07-18

N Engl J Med 2026;395:267-277 — DOI 10.1056/NEJMcpx2411656

本投影片為讀書會共筆整理，僅供教學參考，不構成臨床處置建議。

一句話重點

纖維肌痛症是 CNS 對感覺刺激「過度反應」的 nociplastic pain 代表疾病；特徵為廣泛疼痛 + 睡眠/情緒/疲勞/認知/感官敏感問題。

- 多數可於**基層醫療**成功管理。
- 治療核心 = **安撫過度敏感的 CNS**；衛教與自我照護為基石。
- **NSAID、鴉片類無效**，鴉片類甚至**有害**。

案例引導

- 43 歲**男性**，3 年慢性下背痛，對肌鬆劑、NSAID、硬脊膜外類固醇、PT 皆無效
- ESR/CRP/TSH/CBC/肝功能正常；MRI 僅輕度退化
- 多處疼痛 + 緊張型頭痛、非心因性胸痛、慢性攝護腺炎、失眠、光敏感
- 想知道：該手術嗎？該用鴉片類嗎？

刻意設計為**男性**——臨床常只在女性考慮此診斷。此為**典型表現**。

盛行率與觀念演進

- 盛行率 **4–6%**；女性為男性 **1.5–2 倍**；醫療費用約 3 倍
- 核心：持續廣泛疼痛 + 睡眠/情緒/疲勞/記憶/感官敏感
- 歷史：fibrositis → fibromyalgia；曾因找不到周邊發炎被質疑
- 近 20 年確立其**客觀神經生物學基礎**

Nociplastic Pain (疼痛第三類)

IASP 2016 承認疼痛可源自 **CNS 本身**，幾乎不需周邊輸入。

路徑	機轉	例子
Top-down	疼痛前 nociplasticity 特徵已存在	ABCD 研究：睡眠/記憶/感官問題 先於 疼痛
Bottom-up	反覆傷害使 CNS 敏感化	自體免疫、關節過動、癌症

治療目標 = **平息 CNS 感覺過度反應**，非修復周邊病理。

慢性重疊疼痛 (COPC)

- NIH 2016 指出 10 種常共病的慢性疼痛：顳顎關節障礙、腸躁症、慢性頭痛、間質性膀胱炎/骨盆痛、慢性下背痛、子宮內膜異位、外陰痛、肌痛性腦脊髓炎...
- ICD-11 將多數 COPC 歸為 **primary pain (原發性疼痛)**

纖維肌痛常「不孤單」——找一個，順手篩其他。

診斷

2016 ACR 診斷標準

- WPI (Widespread Pain Index) : 19 部位慢性疼痛
- SSS (Symptom Severity Scale) : 疲勞、睡眠、情緒
- 推定診斷：身體地圖 5 區中 ≥ 4 區疼痛 + Fibromyalgia Severity score > 13

關鍵：纖維肌痛不是排除性診斷，不論是否有其他診斷皆可診斷。

檢驗與輔助工具

- **無專一性檢查**；檢驗僅排除擬似病：
ESR/CRP、TSH、CBC、肝功能
- 輔助：**PROMIS-29+2**（身心症狀）、**COPC-Screener**（篩重疊疼痛，<15 分鐘）
- workup 依情境：兒童期緩慢演變 → 極少檢查；急性發作 → 較完整檢查

治療

非藥物治療（第一線基石）

三大指引共識：**多專科整合** > **單一療法**、優先衛教、病人主動參與。

療法	疼痛 SMD	效果量
運動（有 氧 /肌力/柔軟度）	-1.05 ~ -1.39	大
CBT / ACT	-0.45 ~ -0.81	中-大
多專科整合治療	-1.15	大
氣功 / 太極 / 瑜伽	-0.54 ~ -0.72	中

運動須 "start low, go slow" —— 否則反而惡化症狀。

藥物治療（效果量皆小，一次加一種）

類別	代表藥（FDA 核准★）	重點
TCA	amitriptyline、nortriptyline、 sublingual cyclobenzaprine★	睡前給藥增強催眠；amitriptyline 對睡眠效果大
Gabapentinoid	pregabalin★ 、gabapentin	益處多源自改善深層睡眠
SNRI	duloxetine★ 、 milnacipran★	正腎上腺素活性強者較有效
合併	gabapentinoid（睡前）+ SNRI（白天）	止痛 68% vs 單用 39–42%

避免使用

- acetaminophen、NSAID、鴉片類一般無效
- 鴉片類應避免：opioid-induced hyperalgesia、成癮/過量、全因死亡率近乎倍增（MI、跌倒、自殺、車禍）
- 若必須用 → 混合型 agonist（tramadol / buprenorphine / tapentadol）
- 低劑量 naltrexone 可能有益

不確定領域與新興療法

- **無血液/客觀診斷檢查**；「自體免疫/小纖維神經病變/純心理」說法**均未證實**
- 神經刺激：**tDCS**、**TMS**（具前景待試驗）、**TENS**
- **Cannabinoid**：CBD 單用 vs 需少量 THC，待釐清
- 其他：光療、低強度聚焦超音波、psychedelics、resilience training

Take Home Message

作者對案例的處置

- 典型纖維肌痛，不需轉次專科或進一步檢查；多數可基層處理
- 保證不需手術
- 先給睡前低劑量 TCA (cyclobenzaprine / nortriptyline) + 漸進式運動 (瑜伽/步行)
- 無反應 → 改 SNRI 或 gabapentinoid + 多元整合非藥物療法
- 全程避免鴉片類

參考文獻

1. Williams DA, Clauw DJ. Fibromyalgia. *N Engl J Med*. 2026;395(3):267-277.
2. Clauw DJ. Fibromyalgia: a clinical review. *JAMA*. 2014;311(15):1547-1555.
3. Fitzcharles MA, Cohen SP, Clauw DJ, et al. Nociceptive pain. *Lancet*. 2021;397:2098-2110.
4. Wolfe F, Clauw DJ, Fitzcharles MA, et al. 2016 revisions to fibromyalgia diagnostic criteria. *Semin Arthritis Rheum*. 2016;46:319-329.
5. Macfarlane GJ, et al. EULAR revised recommendations for fibromyalgia. *Ann Rheum Dis*. 2017;76:318-328.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC